EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Elemento	Descripción
Código	08-03-1.0
Nombre	Tamizaje bioquímico para la detección temprana de enfermedad renal crónica (ERC) en población de alto riesgo (HT, DM2).
Definición conceptual	Porcentaje de personas atendidas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas condiciones, que cuentan con pruebas de laboratorio completas orientadas a la detección de ERC, del total de las personas atendidas con dichos diagnósticos. Pruebas para detectar ERC: creatinina sérica, índice albuminuria/creatinuria (IAC) o índice proteinuria-creatinuria (IPC). Creatinina sérica: insumo para el cálculo de la Tasa de Filtración Glomerular estimada (TFGe), mediante la ecuación de la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). IAC: conocida como relación albúmina/creatinina (RAC), se realiza a partir de una única muestra de orina que determina la proporción entre la cantidad de albúmina y creatinina urinaria. Constituye la primera opción recomendada para el tamizaje de proteinuria. IPC: cociente entre la concentración de proteínas totales y la de creatinina en una muestra aislada de orina. Se considera la segunda opción para el tamizaje de proteinuria cuando no se dispone la determinación de RAC. Pruebas completas: Cuando presenta resultados de ambas pruebas orientadas a la detección de ERC (creatinina sérica y IAC o, en su defecto, IPC). Pruebas incompletas: Cuando no presenta resultado de una o ninguna de las pruebas. Incluye: • Población de 20 años y más con diagnóstico de HT, DM2 o con ambas condiciones, que consultan por primera vez en el año, identificadas mediante los siguientes códigos: CIE-10: I10. Hipertensión esencial (primaria), E11. Diabetes mellitus no insulinodependiente. • Pruebas de laboratorio clínico: Listado de primer valor de creatinina sérica, IAC o IPC durante el año evaluado, que cuenten con fecha de toma de la muestra y resultado. Excluye: • Población de 20 años y más con diagnóstico de ERC (CIE-10: N18.0–N18.9), en el año anterior.
Variables involucradas en la medición	• Número de personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, atendidas de primera vez, con pruebas completas en el periodo. • Número de personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, atendidas de primera vez en el periodo.

EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR

Fórmula de cálculo	$\frac{\text{Número de personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, atendidas de primera vez, con pruebas completas en el periodo.}}{\text{Número de personas de 20 años y más con HT, DM2 o ambas, atendidas de primera vez en el periodo.}} \times 100$	
Desagregación	Nivel de atención	Primer Nivel
	Componente de la prestación	Consulta externa
	Componente de la atención integral	Prevención
	Temática	Enfermedades Crónicas no Transmisibles – ERC
Línea base	A definir con los resultados del análisis 2026 de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud.	
Meta	Quinquenal: en construcción	
Periodicidad	Anual	
Fuente de información	Expediente Digital Único en Salud (Cubo DCSS EPSS Cardiovascular, Cubo DCSS EPSS Generales, Reporte HT) • Consultas de primera vez por HT o DM2. • Consultas en el año anterior por ERC. • Pruebas de laboratorio clínico registradas en el énfasis correspondiente que cuenten con fecha y resultado. Sistemas de laboratorio clínico (LABCORE, Sistema Integrado de Laboratorio Clínico). • Creatinina sérica, IAC, IPC. Fuente alternativa de resultados de laboratorio clínico	
Clasificación	Indicador de Proceso	
Presentación de resultados	• Reporte de resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual y Monitoreos) • Informe de Resultados de la Evaluación de la Prestación de Servicios de Salud del Primer Nivel de Atención (Anual).	
Comentarios generales		